PROTOCOLLO 58

Protrusione e retrusione controllate

Allenare il controllo antero posteriore della mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Click in apertura
- ✓ Dolore in protrusione
- ✓ Controllo motorio ridotto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Denti separati, labbra rilassate.



Protrusione

Porta la mandibola in avanti lentamente.



Mantenimento

Mantieni 3 secondi.



Ritorno

Ritorna lentamente in posizione di riposo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	3 secondi
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Movimento piccolo e controllato
- ✓ Verifica l'assenza di dolore
- ✓ Utile nei click che scompaiono in protrusione

Errori da evitare

- ! Protrusione eccessiva
- ! Velocità elevata
- ! Contrazione del collo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Protrusione lenta	Avanti e indietro con controllo	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La protrusione controllata migliora la coordinazione tra condilo e disco.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.